

УДК: 618.19-006.6

Е.А.Имангалиев

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МАСТЭКТОМИИ С ТРАНСПЕКТОРАЛЬНОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ

Аннотация. Радикальная мастэктомия приводит к грозным осложнениям, которые связаны с этапом лимфодиссекции. Поэтому самым адекватным методом борьбы с ПМЭС остается способ интраоперационной профилактики. Целью настоящей работы является улучшение результатов хирургического лечения рака молочной железы. Современные тенденции в онкохирургии должны быть направлены не только на радикальность, но и на максимальное сохранение анатомических структур. Предлагаемый способ модифицированной мастэктомии значительно снижает выраженность ПМЭС и должен шире применяться при радикальных операциях.

Ключевые слова: Радикальная мастэктомия, лимфодиссекция, интраоперационная профилактика.

Радикальная мастэктомия приводит к развитию сложного комплекса – постмастэктомического синдрома (ПМЭС), который отличается разнообразием симптомов и клинических форм, как лимфорея, болевой синдром, отек руки, ограничение движений в плечевом суставе, брахиоплексопатия. Самые грозные осложнения мастэктомии связаны не с удалением молочной железы, а с этапом лимфодиссекции. Поэтому самым адекватным методом борьбы с ПМЭС остается способ интраоперационной профилактики.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является улучшение результатов хирургического лечения рака молочной железы путем снижения частоты и выраженности постмастэктомических осложнений за счет выполнения модифицированной функционально-щадящей мастэктомии.

Материалы и методы: Известный способ радикальной мастэктомии с сохранением грудных мышц (Madden, 1965), который, помимо удаления молочной железы и клетчатки подмышечной, подлопаточной и подключичной областей с соответствующими лимфатическими узлами, предусматривает удаление вместе с фасцией покрывающей заднюю поверхность большой грудной мышцы и переднюю поверхность малой грудной мышцы и торакоакромиального сосудисто-нервного пучка, что влечет за собой развития комплекса ПМЭС. В 2012 году, во время обмена опытом коллегами Онкологического Центра г. Урумчи (КНР), заметили что, онкологи проводили лимфодиссекцию при мастэктомии щадящим методом, что снижало риск ПМЭС. Алгоритм выполнения подобной операции, мы встретили в патенте № 2185782 РФ и диссертации Рыбина О.Н. 2006 г., отличающийся от классической модификации, макси-

мально обеспечивающая атравматичное удаление тканей, расположенных на этой структуре. Типично осуществляется удаление молочной железы вместе с фасцией, покрывающей переднюю поверхность большой грудной мышцы, и удаляется клетчатка подмышечной и подлопаточной областей. Далее удаляется клетчатка между большой и малой грудными мышцами вместе с фасциями, покрывающими заднюю поверхность большой грудной и переднюю поверхность малой грудной мышц. При этом необходимо сохранить сосудистые и нервные стволы, локализующиеся в межмышечном пространстве, освободив их, насколько это возможно, от жировой клетчатки. Затем, отступая вниз на 2-3 см от нижнего края ключицы, тупым путем разводятся волокна большой грудной мышцы и транспекторальным путем осуществляется отделение подключичной клетчатки сверху, медиально - книзу и латерально, сохраняя все ветви торакоакромиального сосудисто-нервного пучка, за исключением ключичной ветви. При выполнении вышеописанного способа радикальной мастэктомии осуществляется профилактика негативных последствий классической операции Маддена (уменьшения проявлений так называемого постмастэктомического синдрома). Он отличается от операции Маддена тем, что предусматривает освобождение от клетчатки всех сосудистых и нервных стволов, находящихся между малой и большой грудными мышцами и в ключично-грудном треугольнике, через «пекторальное окно».

Данный способ радикальной мастэктомии осуществлен у 10 пациенток, страдающих раком молочной железы 2а и 2б стадии. Клинические наблюдения показали, что лимфодиссекция транспекторальным доступом с сохранением торакоакромиального сосудисто-нервного пучка не сказывается на продолжительности операции, не увеличивает количества осложнений в ближайшем послеоперационном периоде и способствует более раннему, практически без ограничений восстановлению функции верхней конечности. Клинически значимых признаков лимфопатической недостаточности не было выявлено ни у одной из пациенток из числа тех, кому было выполнено предложенное оперативное вмешательство.

Закключение. Современные тенденции в онкохирургии должны быть направлены не только на радикальность, но и на максимальное сохранение анатомических структур. Предлагаемый способ модифицированной мастэктомии значительно снижает выраженность ПМЭС и должен шире применяться при радикальных операциях.

**Тұжырым.
Е.И.Имангалиев**

«Облыстық онкологиялық диспансер» Талдықорған қ.

**Модифицирленген мастэктомия транспекторальды
лимфодиссекциясы әдісін қолданудағы тәжірибе**

Радикалды мастэктомия күрделі асқынуларға алып келуі мүмкін, олар өздігімен лимфодиссекцияның кезеңіне байланысты. Сондықтан ПМЭС-пен күресте ең қолайлы әдістердің бірі интраоперационды профилактика болып табылады. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты сүт безі қатерлі ісігінің хирургиялық емінің нәтижелерін жақсарту. Онко-хирургияда заманауи үрдістер радикалдылыққа ғана емес, сондай-ақ максималды түрде анатомиялық құрылымды сақтауға бағытталған. Ұсынылып отырған модифицирленген мастэктомия әдісі ПМЭС-тің айқындылығын төмендетеді, сондықтан радикалды операцияларды кеңінен қолданылуы қажет.

Түйінді сөздер: радикалды мастэктомия, лимфодиссекция, интраоперационды профилактика.

E.A.Imangaliyev

Regional Oncology Center, city Taldykorgan

**The experience of applying the modified mastectomy
with lymphodissection**

The Radical mastectomy leads to formidable complications that relate to the stage of lymphodissection. Therefore the most appropriate method of combating primary care remains the way an intraoperative prevention. The purpose of this work is to improve the results of surgical treatment of breast cancer. Modern trends in surgery should be directed not only at the radical care, but the maximum preservation of anatomical structures. The proposed method of retrofit mastectomy significantly reduces the hue of ПМЭС and should be more widely used when radical operations.

Key words: radical mastectomy, lymphodissection, intraoperational prevention.